

Objectifs

DYSPLASIE CERVICALE

I-Introduction :

- * Les dysplasies cervicales concernent les cellules : trouble de différenciation et de maturation → désorganisation architecturale de l'épithélium, avec une membrane basale respectée.
- * C'est un sujet d'actualité, touchant la femme jeune.
- * Ce sont des lésions avec un potentiel évolutif vers un cancer micro-invasif.
- * Ce sont des lésions infra-cliniques nécessitant donc un dépistage.
- * Une bonne PEC d'une dysplasie cervicale assure une prévention d'un kc du col.



- * La dysplasie ou néoplasie cervicale intra-épithéliale (CIN) se développent à partir de la jonction pavimento-cylindrique et de la zone de transformation anormale.
- * Il s'agit d'un éventail de lésions caractérisées par une désorganisation architecturale liée principalement à un trouble de la différenciation et une prolifération de cellules atypiques pouvant aboutir à un cancer (évolution lente).

II-Epidémiologie :

1-Fréquence :

- * Le kc du col est le 2^{ème} cancer féminin après celui du sein (2000 nouveaux cas/an).
- * Le dépistage de dysplasies connaît une frq maximale entre 20-40 ans (age jeune++), et est exceptionnel >60ans.

2-FDR :

- ✓ Rapports précoces
 - ✓ Rapports non protégés
 - ✓ Bas nv socio-économique
 - ✓ Partenaires multiples
 - ✓ Multiparité
 - ✓ Tabac
 - ✓ ID
- INFECTION

III-Physiopathologie :

1-Epithélium cervical :

*De point de vue anatomique:

- Le col est la portion fibromusculaire basse de l'utérus. Il est de forme cylindrique ou conique.
- Chez la nullipare il mesure 2,5cm de long et 2,5cm de largeur. Chez la multipare, il perd au contraire de sa longueur.
- La $\frac{1}{2}$ supérieure du col rencontre le corps musculaire de l'utérus au niveau de l'OCI.
- La portion du col s'étendant à l'extérieur de l'orifice externe est appelée « exocol ». C'est la partie aisément visible lors d'un examen visuel avec le spéculum.
- La portion du col située à l'intérieur de l'orifice externe est appelée « endocol », pour la visualiser, il est nécessaire d'étirer ou de dilater l'orifice externe.

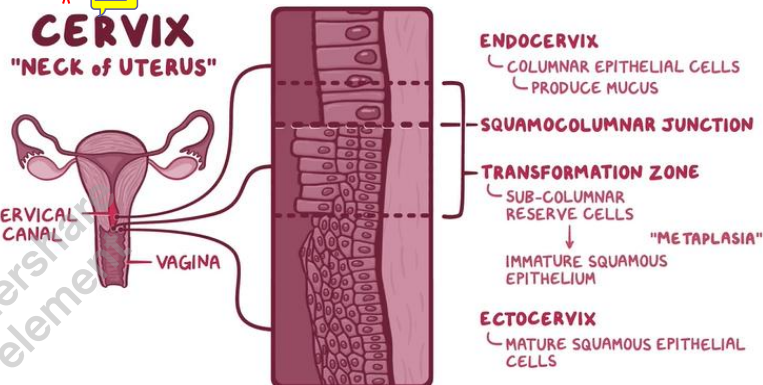
*De point de vue histologique :

- L'endocol est recouvert d'un épithélium cylindrique, glandulaire, fait d'une seule couche de cellules en continuité avec l'épithélium glandulaire endométrial sécrétant la glaire sous l'influence des œstrogènes → Une couche de cellule, aspect rouge et brillant.

Cet épithélium tapisse les invaginations ou cryptes de l'endocol.

- L'exocol est recouvert d'un épithélium malpighien, pavimenteux, stratifié, en continuité avec l'épithélium malpighien vaginal → pluri-stratifié, aspect rose et lisse.

-La zone de jonction est la région d'affrontement des 2 épithéliums. Sa situation sur le col varie en fonction des événements de la vie de la femme, elle est en remaniement permanent → C'est là où naît le cancer ⇔

FCV_x

2-Ectropion ou ectopie :

- * On parle d'ectropion lorsque le tissu cylindrique occupe autour de l'orifice externe >0,5 cm de rayon.
- * Il se définit par la présence d'épithélium cylindrique endocervical éversé sur l'exocol, ce phénomène se traduit par l'apparition d'une large zone rougeâtre entourant l'orifice externe.



- * L'épithélium, endocervical normal n'a pas du tout le même aspect que celui de l'exocol classique. Il est plus rosé, semble granuleux et peut inquiéter à tort un examinateur inexpérimenté. Avec le temps, cet épithélium va se transformer en un épithélium pavimenteux normal (métaplasie).
- * L'éversion est plus prononcée sur les lèvres post et ant de l'exocol que sur les lèvres latérales.
- * Dans l'ectropion, on trouve toute la muqueuse, y compris les cryptes et le stroma sous-jacent qui s'éverse, et c'est dans cette région que se produisent non seulement la transformation physiologique normale qu'est la métaplasie pavimenteuse mais aussi les transformations anormales à l'origine du kc du col.
- * En revanche, la définition de l'adénose est beaucoup plus simple puisque le terme est utilisé en présence d'épithélium cylindrique sur les parois vaginales.

* Adénose : hyperplasie glandulaire d'un tissu glandulaire

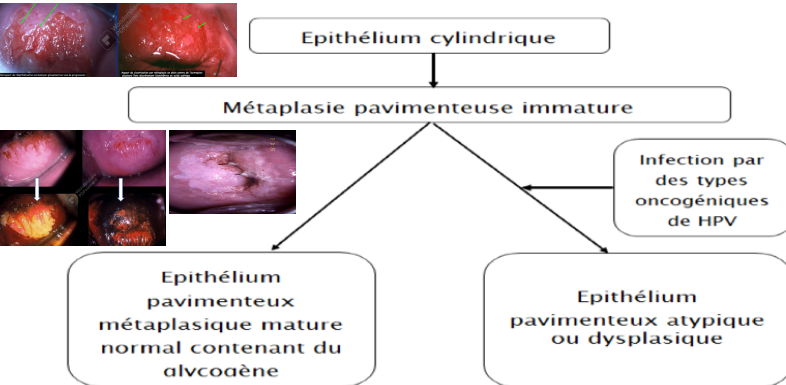
*Parfois, l'ectropion peut s'infecter ou s'irriter et se manifester par des métrorragies minimales. Ce phénomène n'a aucune gravité, et sa prise en charge repose sur la prescription d'antiseptiques locaux.

3-Métaplasie pavimenteuse :

*C'est la transformation de l'épithélium cylindrique ectopique éversé sur l'exocol en épithélium malpighien → C'est un phénomène physiologique de réparation.

*Elle se fait par prolifération des cellules de réserve indifférenciées, disparition des cellules cylindriques, et différenciation malpighiennes des cellules de réserve.

*La réépithélisation peut être **typique régulière** (à son début sur le FCV on notera une **hyperplasie des cellules réserve**, pour aboutir à un épithélium malpighien).



*La réépithélisation peut être influencée par le milieu hormonal, le pH vaginal acide.

4-HPV :

*C'est un virus à ADN, à tropisme **cutané-muqueux**.

*Il comprend 120 sérotypes, dont :

16, 18, 31, 33... : à **haut risque oncogène**

6, 11, 42, 44... : à **bas risque oncogène**

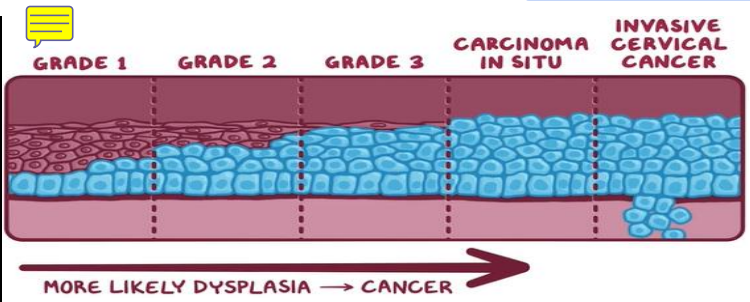
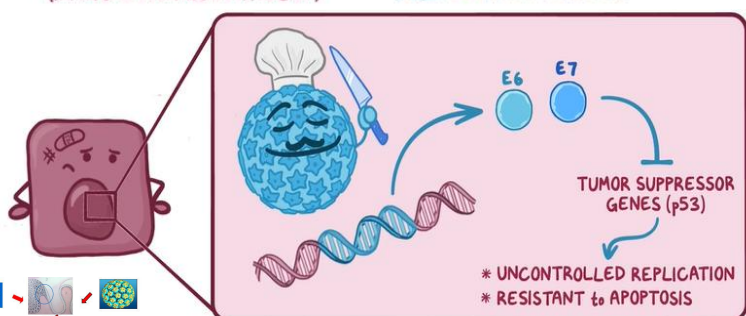
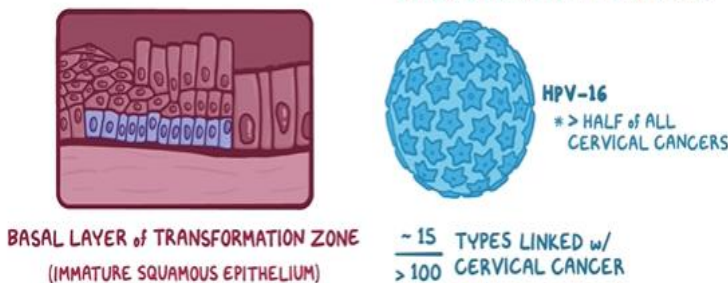
*L'infection à HPV se passe au nv de la jonction du col : présence d'ADN viral dans les assises basales.

*S'en suit une persistance de l'infection virale suite à des **cofacteurs** : HSV2, tabac, ID..etc

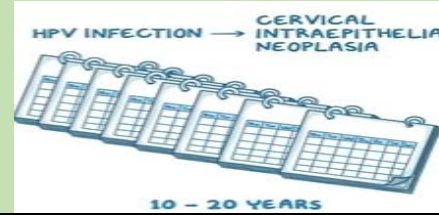
→ Facteur important pour le dvpmt des lésions.

CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA/ SQUAMOUS EPITHELIAL LESION

MOSTLY CAUSED BY HPV INFECTION



*Beaucoup d'infections à HPV passent parfaitement asymptomatique responsable d'infections le plus souvent dites transitoires, par contre un nombre limité de femmes garderont les papillomavirus latents ou quiescents durant des mois voire des années et pourront alors développer en cas de persistance de l'infection une CIN qui pourrait aboutir à un Kc des années plus tard.



IV-Anatomopathologie :

1-Cytologie :

Bethesda 2014

Classification Bethesda 2001 :

LIBG (lésions intra-épithéliales de bas grade)	*Noyaux : de taille augmentée, hyperchromatiques homogènes, réguliers *Cytoplasme : présence d'un halo clair péri nucléaire et d'une densification cytoplasmique périphérique qui définissent les koilocytes
LIHG (lésions intra-épithéliales de haut grade)	*Noyaux de contours irréguliers, hyper chromatiques hétérogènes *Le rapport nucléocytoplasmique est augmenté *Cellules isolées ou en amas
AGC (atypical glandular cells)	*Atypie des cellules glandulaires
ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance)	*Atypies des cellules malpighiennes, de significations inconnues
ASC-H (atypical squamous cells of undetermined significance, high grade not excluded)	*Atypie des cellules malpighiennes, ne permettant pas d'exclure le diagnostic de lésions malpighiennes intra-épithéliales de haut grade

* Dans les LIBG on peut trouver des modifications nucléaires et cytoplasmiques caractérisant la **parakératose** qui associe pycnose, allongement, hyperchromatisme, irrégularité nucléaire associée à une densification et éosinophilie du cytoplasme avec augmentation du rapport nucléocytoplasmique. La parakératose atypique n'est pas spécifique d'une lésion intra-épithéliale de bas grade, elle peut accompagner une lésion de grade plus élevé ou un

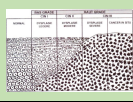
carcinome malpighien invasif kératinisant.**2-Histologie :**

QE!!

Reagan 1958	Richart 1991	Meisels 1976	Bethesda 2001
		Condylome	
DL	CIN 1		LGSIL
DM	CIN 2		
DS	CIN 3		HGSIL
CIS			
KMI	KMI		KMI

***KMI : kératites à médiation immune**

- *DL : dysplasie légère
- *DM : dysplasie moyenne
- *DS : dysplasie sévère



Classification de Bethesda	Classification de Richart	Classification de Meisels	Classification de Bethesda
Lésions intra-épithéliales à bas grade (LISB)	CIN1	Dysplasie légère	Atypies cellulaires localisées au tiers inférieur de l'épithélium
Lésions intra-épithéliales à haut grade (LISH)	CIN2	Dysplasie moyenne	Atypies élargies au tiers supérieur de l'épithélium
	CIN3	Dysplasie sévère	Atypies au tiers supérieur de l'épithélium (carcinome in situ)

1-Dépistage et diagnostic :**1-Clinique :**

*Les CIN sont des lésions infracliniques et asymptomatiques. On s'oriente par l'interrogatoire (FDR), et l'examen du col :

- Col rouge
- Leucoplasie
- Condylome du col, vagin, vulve ou périnée
- Papillomatose Bowenoid

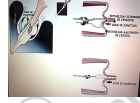
**2-FCV : dépistage :**

*Il s'agit d'un plvmt cellulaire cervico-vaginal, qui se fait entre le 8^{ème} et le 12^{ème} jour du cycle, 1 mois après l'infection.

*Il faut éviter les rapports sexuels 48h avant le FCV.

***Rythme :**

- Dès le 1^{er} rapport : **1 fois/ an pdt 2ans,**
- Puis **1 fois / 3 ans**



*Le 1^{er} frottis cervico-utérin doit être réalisé à 25 ans, contrôlé un an plus tard puis réalisé tous 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. -HAS 2010

*Schématiquement, on peut dire que tout FCU anormal nécessite la réalisation d'une colposcopie.

3-Colposcopie : localisation :

*Chez la femme en période d'activité génitale : doit être réalisée idéalement en 1^{ère} phase du cycle pour bénéficier de l'ouverture du col liée à l'imprégnation oestrogénique.

*Chez la femme ménopausée : doit être réalisée après préparation aux oestrogènes par voie locale ou général

*L'image colposcopique correspond à la visualisation du tissu conjonctif à travers un écran qui est l'épithélium de recouvrement.

*On utilise une loupe binoculaire : x12 – 40 fois.

*Elle comporte des temps successifs :

Sans préparation :

- *L'examen se complète après avoir débarrassé le col de ses sécrétions en prenant garde de ne pas le faire saigner par un essuyage traumatisant, c'est l'intérêt de la pissette de sérum physiologique.
- *L'épithélium de recouvrement du col est normalement rose uniforme.
- *C'est le moment de l'examen où on visualise le mieux les vaisseaux. S'ils existent, il faut analyser avec soin leur



disposition, leur trajet, leur calibre.

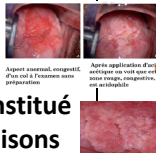
A la lumière verte**Application d'acide acétique à 3% :**

*Attende de 30 sec à 1 minute.

*Col normal : Pas de blanchiment de l'épithélium malpighien qui pâlit à peine.

-L'épith cylindrique devient facile à identifier constitué de papilles coalescentes (arrondies en grains de raisons parfois plus allongées en doigt de gant), translucide.

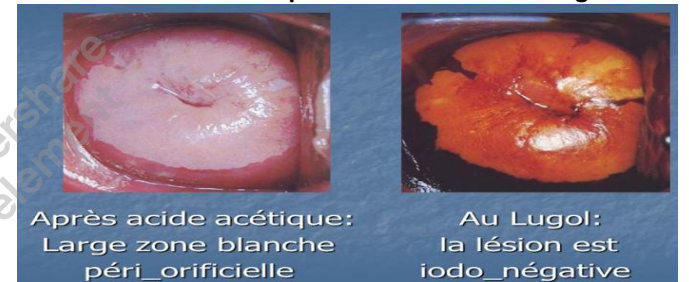
-La jonction pavimento-cylindrique peut être identifiée souvent surlignée de blanc traduisant le surplomb de l'épith malpighien au-dessus du glandulaire. Elle est située de façon variable (orifice anatomique du col ++, souvent +/- extériorisée chez la femme en activité ovarienne, parfois intériorisée → Il faut ouvrir le col à la pince ou au spéculum endocervical).

**Application de solution de Lugol :**

*C'est le test de Schiller.

*La solution iodo-iodurée colore en brun-acajou l'épithélium malpighien lorsqu'il est normal, c.à.d différencié et mature car il contient du glycogène dans ses couches superficielles.

*Les zones où il n'y a pas d'épith malpighien ou un épith anormal ne se colorent pas et sont dites iodo-négatives.



*Elle permet le grossissement du col utérin lors de l'examen visuel permettant ainsi de repérer des anomalies au niveau de la muqueuse, d'en préciser la topographie (zone de jonction/ orifice externe) et la sévérité, et de diriger les biopsies afin d'aboutir au diagnostic des lésions, et de surveiller avant et après TRT.

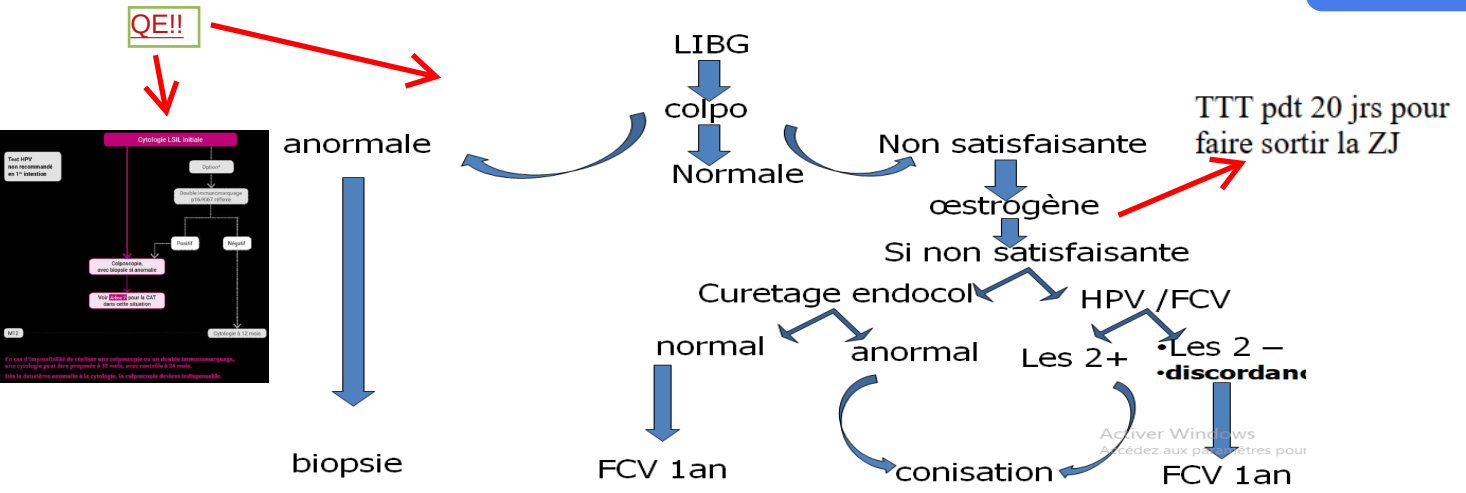
*Intérêt des temps de la colpo :

-Sans prépa : C'est le moment de l'examen où on visualise le mieux les vaisseaux.

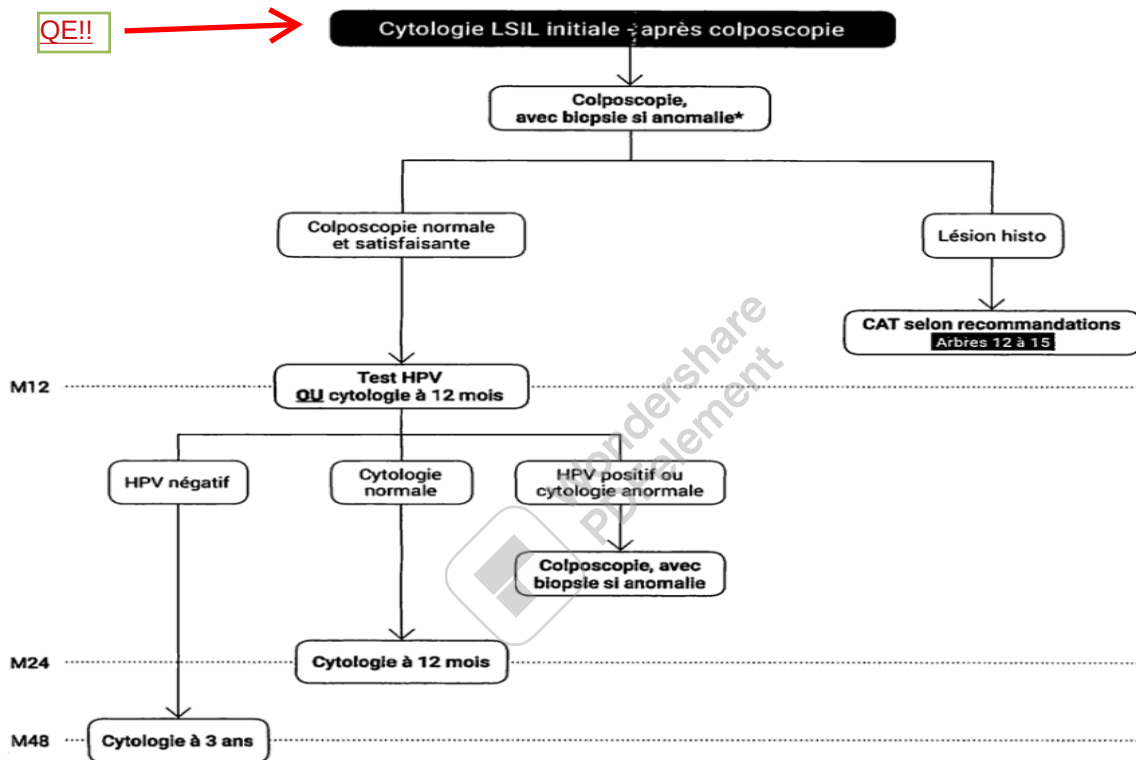
-Acide acétique : visualiser la zone de jct ⇔ cette zone est très importante car c'est à ce niveau que débutent les lésions. Quand elle est identifiée, la colposcopie est dite concluante, significative ou satisfaisante

-Lugol : Les lésions virales à papillomavirus humains (HPV) comportent des cellules à noyau volumineux, souvent multiples, ce qui entraîne une réaction acidophile d'un blanc brillant, neigeux, survenant plus tardivement. Le blanchiment de l'épithélium est extrêmement variable, il dépend en outre de la production de kératine en surface. L'application de solution iodo-iodurée de lugol colore en brun-acajou les cellules matures contenant du glycogène de l'épithélium malpighien. Il n'y a pas de coloration si les cellules sont indifférenciées ou immatures.

*Les indications de la colposcopie :



ARBRE 7 Cytologie LSIL initiale (2) : conduite à tenir à partir de la colposcopie

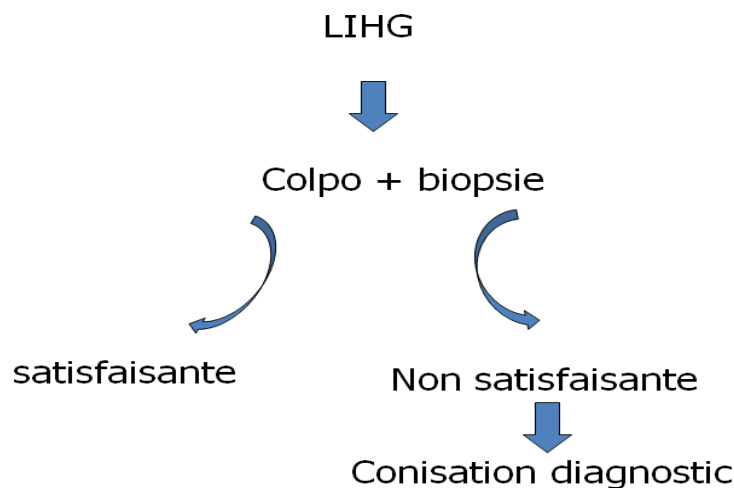


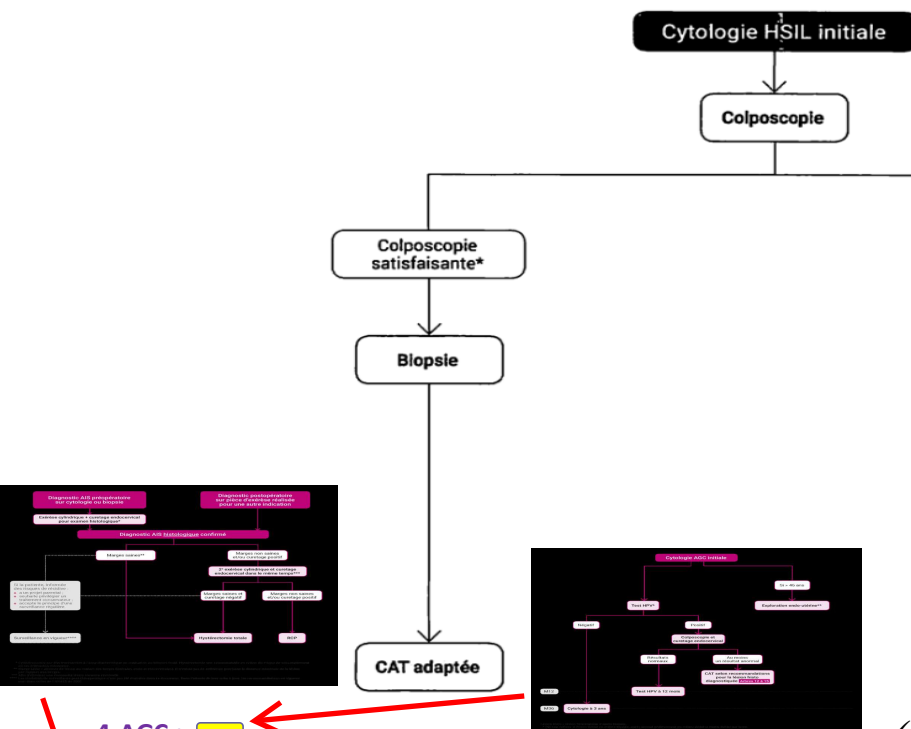
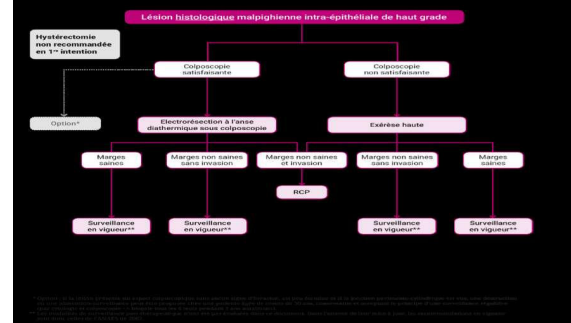
ARBRE 12 - Lésion histologique malpighienne intra-épithéliale de bas grade après cytologie initiale ASC-II, AGC ou HSIL

ARBRE 13 - Lésion histologique malpighienne intra-épithéliale de bas grade après cytologie initiale ASC-II, AGC ou HSIL

*Si la colpo est non satisfaisante, here is la CAT (up), si elle est normale (up too), si c'est anormal et satisfaisante (check PEC à la fin)

3-LIHG :



**4-AGC :**

Atypies glandulaires → Colpo + Biopsie +/- Curetage de l'endocol

5-AIS : adénocarcinome in situ :

AIS → Conisation + Curetage de l'endomètre

VII-Formes cliniques :**1-Grossesse :**

*La grossesse n'est pas le moment idéal du dépistage, à cause de l'imprégnation hormonale qui génère un état d'hyperplasie + une inflammation.

→ Il faut saisir l'occasion lors du 1^{er} T, car l'ectropion est beaucoup plus marqué lors de la grossesse

→ Extériorisation et bonne corrélation cyto-histologie.

*CAT :

-LIBG/LIHG/AGC → Colpo + biopsie, sauf LIBG : en fin de grossesse

*Le curetage de l'endocol est Cl+++.

2-Ménopause :

*Chez la femme ménopausée, on se retrouve devant des cas de :

-Faux négatifs : sténose cervicale ; zone de jct dans l'endocol

-Faux positifs : atrophie

→ Œstrogène + microcolposcopie

3-Col traité :

*Sur un col traité, on peut trouver la fibrose cicatricielle, une inflammation, comme on peut ne pas voir la zone de jonction → Si doute : **conisation diagnostique**.

VIII-Diagnostics différentiels :

*Métoplasie épidermoïde immature

*Hyperplasie des cellules basales et parabasales

*Pseudokoilocytes (atypies de réparation)

IX-Evolution :

*L'évolution se fait vers :

✓ Guérison

✓ Stabilisation : 60%

✓ Aggravation des LIBG : 10%

✓ Aggravation des LIHG : 20-50%

*Classiquement, on note :

1^{ère} modification cellulaire → 3ans → LIHG → 10ans → Cancer

*Actuellement, l'évolution est beaucoup plus rapide.

X-PEC des dysplasies confirmées par histologie :

1-But :

*Guérison des dysplasies

*Prévention du cancer col

*Éviter les récides

*Faire un TRT conservateur (femmes jeunes, maladie locale)

2-Moyens :**2.1-TRT médical :**

*5FU

*Podophylline

*Podophylotoxine

*Interféron

2.2-TRT destructeur (moyens physiques) :

*Thermocoagulation

*Cryocoagulation

*Diathermo-coagulation

*Laser CO2++++

2.3-TRT chirurgical :

*Hystérectomie

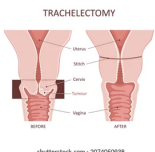
*Trachelectomie

*Conisation par : bistouri froid/ laser/ anse diathermique

→ Histologie importante pour confirmation du passage in sano

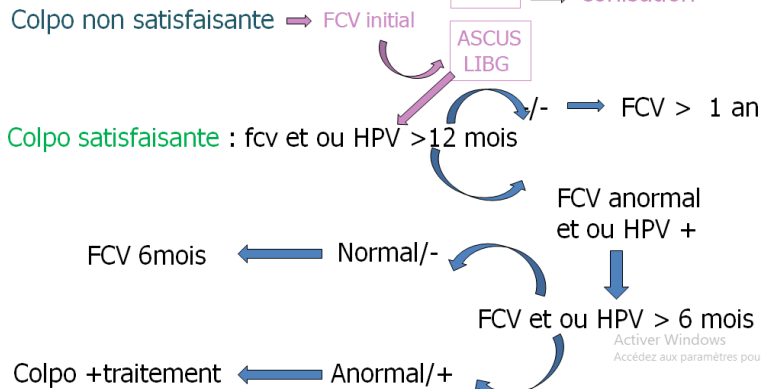
3-Indications :**3.1-LIBG :**

*Une LIBG documentée par analyse histologique ne



doit pas être traitée car la **régression spontanée et complète** est très fréquente. Une **abstention thérapeutique avec mise en place d'une surveillance** est donc indiquée comme suit :

LIBG



*Traitement uniquement si la lésion **persiste au moins 18 mois** ou si la surveillance de la patiente est difficile (patiente indisciplinée).

*On privilégie alors le traitement :

- **Destructeur** : vaporisation au **laser** quand la zone de jonction est vue (femme jeune)
- **Conisation** : zone de jonction non vue

3.2-LIHG :

*Une LIHG documentée par analyse histologique impose la **resection chirurgicale** : méthode de référence :

-A l'anse diathermique ou conisation, à 5 mm de la lésion en surface, à 1 cm dans l'endocol.

*On peut adopter la **destruction** si **âge jeune** avec un **désire de grossesse** : zone de jct soit être vu en **totalité**. La patiente doit être **compliante** avec une surveillance garantie.

*L'**hystérectomie** se fait si femme d'âge **avancé** et/ou lésions associées.

*Cas de grossesse :

-Si **concordance cyto-colpo-histo** :

>Pas de suspicion d'invasion : **surveillance jusqu'au 3^{ème} mois du post-partum**

>Invasion : **conisation diagnostique**

-**Discordance** : colpo/mois → **Réévaluation 3 mois en post-partum**

3.3-ADK in situ :

*Hystérectomie en fonction de la multifocalité et de la hauteur de la lésion.

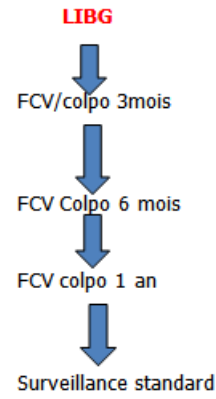
4-Surveillance :

*Pour guetter :

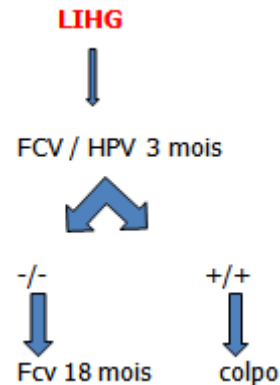
- Les complications : infertilité, complications obstétricales, endométriose..

- Une récurrence

4.1-LIBG :



4.2-LIHG :



5-Prévention : VACCIN + DEPISTAGE

*Il existe deux vaccins anti-HPV :

-Le **Gardasil®** est un vaccin tétravalent prévenant la survenue d'une infection à 4 types différents de Papillomavirus Humains (HPV) :

2 HPV de haut risque (HPV 16 et 18) et 2 HPV de bas risque (HPV 6 et 11).

→ 0.5 ml à 0, 1 et 6 mois

-Le **Cervarix®** est un vaccin bivalent prévenant la survenue d'une infection aux HPV de haut risque de type 16 et 18

→ 0.5 ml à 0, 2 et 6 mois

*En IM au nv de la région deltoïdienne, chez les filles de **14 ans (avant le 1^{er} rapport sexuel)**

*En général, le vaccin est efficace entre 15-23 ans, au plus tard 1 an après le 1^{er} rapport sexuel.

6-Nouveautés :

***Cervicographie par acide acétique disponible au Maroc +++**

***Dépistage par test HPV en cours d'évaluation**

***Autodépistage par KIT : Hollande**

Conclusion

